

## Anemia · VCM e investigação dirigida

Comece pelo VCM e pelos reticulócitos. Anemia microcítica pede ferro/talassemia; macrocítica, B12/folato/álcool; normocítica, perda aguda, doença crônica ou hemólise/medula.

### Ferritina com nuance

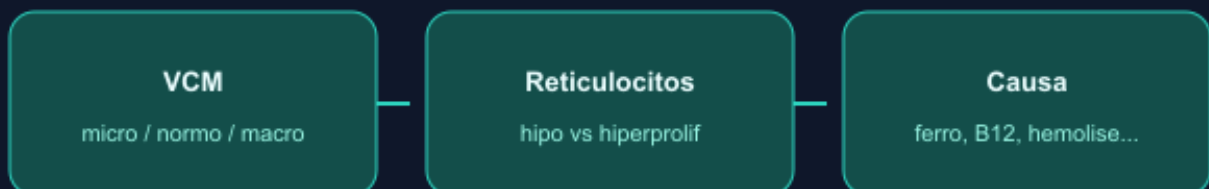
#### Dica - Ferritina com nuance

Ferritina baixa confirma deficiência de ferro. Ferritina 'normal' na inflamação não exclui — use saturação de transferrina e ferro sérico no contexto clínico.

*Fluxo clássico de R1: classifique !' veja se há resposta medular !' escolha o painel etiológico.*

### Raciocínio da anemia

VCM -> reticulocitos -> causa



### Achados que caem em prova

- Ferropênica: VCM!“, ferritina!“; investigar sangramento (GI, menstrual)
- Talassemia minor: VCM muito baixo com anemia leve e RDW relativamente estável
- B12: macrocitose, neuropatia, LDH!“, hipersegmentação; repor parenteral se grave/neurológico
- Hemólise: retic!“, LDH!“, bilirrubina indireta!“, haptoglobina!“

### Microcítica — diferenciação rápida

#### Achado | Ferropênica | Talassemia minor

Anemia | Variável / sintomática | Leve

VCM | !“ | !!“ desproporcional

Ferritina | Baixa | Normal/alta

RDW | Alto | Normal/leve!‘

### Armadilha de prova

#### Atencao - Armadilha de prova

Não feche 'anemia de doença crônica' sem excluir ferro e sangramento oculto quando houver indício. Em idoso com ferropenia, pense em neoplasia GI até prova em contrário.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1